

ВИНЬЕТКИ

Отравления

Пять вызовов: опиоид, бензодиазепин, симпатомиметик,
трициклический антидепрессант и то, что не списывается на
алкоголь

Сначала все задачи, затем все решения.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Ванная

Мужчина, 28 лет. Сосед нашёл на полу ванной. Шприц, жгут. ШКГ 6. Зрачки точечные, на свет не реагируют. ЧД 6 в минуту, SpO₂ 78 %, цианоз. ЧСС 54 в минуту, АД 85/50 мм рт. ст. Кожа холодная, влажная. Следы инъекций. Температура 35,4 °С.

1. Токсидром? Три находки.
2. Действия по приоритету: первое, второе, третье.
3. Налоксон: доза, путь, до какой точки титровать, когда остановиться.
4. Через 45 минут после налоксона снова не дышит. Почему? Что делать?
5. Два осложнения, которые нужно активно искать, если лежал на полу неизвестно сколько.

Случай 2. Пачка феназепама

Женщина, 19 лет, общежитие. Пустой блистер феназепама 2,5 мг × 50 (125 мг) и бутылка вина 0,75 л. ШКГ 13 (E3 V5 M5). Зрачки обычные. ЧД 14 в минуту, SpO₂ 95 %, ЧСС 82 в минуту, АД 100/65 мм рт. ст. Речь смазанная, атаксия. Кожа обычная, тёплая.

1. Какой токсидром? Почему он мягкий при 125 мг феназепама?
2. Нужен ли флумазенил? Минимум три причины не вводить.
3. Что опаснее — феназепам или вино?
4. Тактика на догоспитальном этапе.
5. Что обязательно кроме медицинской помощи при суицидальной попытке?

Случай 3. Клуб

Мужчина, 34 года. Охрана: буянит, бьётся головой. Крайне возбуждён, четверо удерживают. Зрачки широкие, реактивные. ЧСС 142 в минуту, АД 195/110 мм рт. ст., ЧД 28 в минуту, SpO₂ 97 %, температура 39,8 °С. Кожа влажная, горячая. Тризм. Ссадины. Боль за грудиной. ЭКГ: синусовая тахикардия 140, подъём ST в V1–V3 до 1,5 мм. Через 10 минут — генерализованные судороги.

1. Токсидром? Наиболее вероятное вещество?
2. Что является первым приоритетом лечения?
3. При какой температуре это непосредственная угроза жизни? Как охлаждать?
4. Диагноз по боли и ЭКГ? Какой препарат запрещён?
5. Судороги: препарат, доза, путь.

Случай 4. Амитриптилин

Женщина, 42 года. Пустая банка амитриптилина 25 мг × 100 (2500 мг). ШКГ 7 (E1 V2 M4). Зрачки широкие, реакция вялая. ЧСС 128 в минуту, ритм неправильный, АД 80/50 мм рт. ст., ЧД 20 в минуту, SpO₂ 92 %. Кожа сухая, горячая. Живот вздут, перистальтики нет. Подёргивания мышц. ЭКГ: QRS 148 мс, R в aVR 5 мм, QTc 520 мс.

1. Токсидром? Четыре мишени трициклических антидепрессантов.
2. Что означают QRS 148 мс, R в aVR 5 мм и QTc 520 мс?
3. Антидот: доза, путь, механизм, до какой точки титровать.
4. Четыре запрещённых препарата и почему каждый убьёт.
5. Генерализованный припадок: чем купировать и почему это критично?

Случай 5. Третий день пьёт

Мужчина, 55 лет, подъезд. Пьёт третий день, «не может встать». ШКГ 14. Запах алкоголя. ЧСС 96 в минуту, АД 105/70 мм рт. ст., ЧД 18 в минуту, SpO₂ 94 %, температура 35,8 °С. Тремор, нистагм, атаксия. Через 20 минут ШКГ 10. Жена: «таблетки от нервов, белые, маленькие».

1. Минимум пять диагнозов, которые нельзя списать на алкоголь.
2. Какое одно измерение делается первым?
3. Тиамин: зачем, доза, до или после глюкозы?
4. ШКГ упала до 10. Какой диагноз теперь первый?
5. Давать ли флумазенил, если это бензодиазепин?

Решения

Случай 1

1. Опиоидный токсидром. Точечные зрачки, ЧД 6 в минуту, ШКГ 6. Шприц и жгут — контекст, не диагноз.
2. Дыхательные пути и вентиляция. Кислород. Затем налоксон. Антидот не заменяет мешок: брадипноэ 6 и сатурация 78 % убивают раньше, чем подействует препарат.
3. Налоксон 0,4 мг внутривенно, при отсутствии вены — внутримышечно, титровать до появления дыхания, не до «чтобы встал и ушёл». Остановка — когда частота дыхания и сатурация приемлемы. Полный пробуждающий болюс срывает в агрессию и повторную дозу улицы.
4. Короткий период полувыведения налоксона против длинного у многих опиоидов, особенно метадона и фентанила. Повторная доза, готовность к инфузии в стационаре, вентиляция, если снова апноэ.
5. Рабдомиолиз и компартмент после лежания. Гипотермия уже есть. Ищут конечности, не только зрачки.

Случай 2

1. Седативно-гипнотический токсидром, лёгкий: сонливость, атаксия, речь, дыхание 14. Бензодиазепины редко убивают дыхание в моноинтоксикации.
2. Флумазенил не вводить. Смесь с алкоголем. Возможная суицидальная полиинтоксикация, в том числе скрытые трициклические. Хронический приём бензодиазепинов — риск судорог отмены. Флумазенил снимает тормоз и даёт статус.
3. Вино. Алкоголь угнетает дыхание сильнее; смесь двух депрессантов — риск, которого нет у «чистого» феназепама.
4. Дыхательные пути, мониторинг, глюкоза, эвакуация в токсикологию. Уголь на линии обычно уже поздно и при ШКГ 13 с атаксией опасен аспирацией. Флумазенил не входит.
5. Не оставлять одну. Передача в стационар с пометкой суицидальной попытки. Изъятие остатков таблеток. Сообщение по правилам службы о социально опасном состоянии. Юридически это не «отказ, потому что уже лучше».

Случай 3

1. Симпатомиметический токсидром. Наиболее вероятно — кокаин или амфетамин / катинон. Кожа мокрая отличает от антихолинергического: wet = sympathomimetic, dry = anticholinergic.
2. Охлаждение и контроль возбуждения бензодиазепином. Не «антидот», которого нет. Тепло и кислота от судорог убивают сердце.
3. Выше 40 °C — непосредственная угроза, как тепловой удар. Раздеть, обтирание водой с обдувом, лёд на шею, пах и подмышки, холодные растворы. Антипиретики не работают.
4. Ишемия / вазоспазм на кокаине, не классический бляшечный STEMI. Бета-блокатор в изоляции запрещён: остаётся альфа-спазм, давление и коронарный спазм растут.
5. Мидазолам 10 мг внутримышечно или диазепам 10 мг внутривенно. Судороги на стимуляторе — бензодиазепин, не фенитоин.

Случай 4

1. Антихолинэргический токсидром плюс кардиотоксичность трициклических. Четыре мишени: мускариновые рецепторы (сухая кожа, мидриаз, илеус), натриевые каналы (широкий QRS, гипотония), калиевые каналы (длинный QT), альфа-1 (гипотония).
2. QRS 148 мс — блокада натрия, риск судорог и желудочковых аритмий. R в aVR 5 мм — тот же натриевый блок, вектор вправо. QTc 520 мс — блок калия, риск пируэта.
3. Натрия гидрокарбонат. Болюс 1–2 ммоль/кг внутривенно, повтор до сужения QRS или pH около 7,50–7,55. Механизм: натриевая нагрузка, алкалемия, меньше связывания препарата с каналом.
4. Физостигмин — асистолия на трициклических. Класс IA/IC — ещё натриевый блок. Бета-блокатор и верапамил — добить гипотонию. Флумазенил, если смесь с бензодиазепином, — судороги на уже высоком риске.
5. Бензодиазепин. Судороги → ацидоз → ещё сильнее натриевый блок → ещё шире QRS. «Seizures → heat → acidosis → cardiac. Kill the root.»

Случай 5

1. Черепно-мозговая травма. Гипогликемия. Инсульт. Энцефалопатия Вернике. Смешанное отравление. Переохлаждение. Субдуральная гематома у пьющего.
2. Глюкоза. Одно измерение меняет весь вызов.
3. Тиамин 100 мг внутривенно. До глюкозы или вместе с ней. Глюкоза без тиамина у истощённого пьющего может дать острую энцефалопатию Вернике.
4. «Пьяный, который ухудшается» — черепно-мозговая травма, пока не доказано иное. Алкоголь в динамике не падает за 20 минут.
5. Нет. Смесь с алкоголем, неизвестные «таблетки от нервов», возможная травма головы. Флумазенил здесь — судороги и скрытый второй яд.

Основные выводы

№	Вывод
1	Опиоид: сначала вентиляция, потом налоксон до дыхания, не до ярости. Через час может снова встать апноэ.
2	Флумазенил при смеси с алкоголем и при суициде не вводят. Судороги отмены и скрытые трициклические.
3	Мокрая кожа — симпатомиметик. Первое — охлаждение и бензодиазепин. Бета-блокатор в изоляции запрещён.
4	Широкий QRS и R в aVR — гидрокарбонат натрия. Физостигмин плюс трициклические — асистолия.
5	Пьяный, который ухудшается, — травма головы. Глюкоза первая. Тиамин до глюкозы.